



CASO CLÍNICO 2

Entregable 2 y 3

Grupo 7

Punto 1

INFORMACIÓN PERSONAL

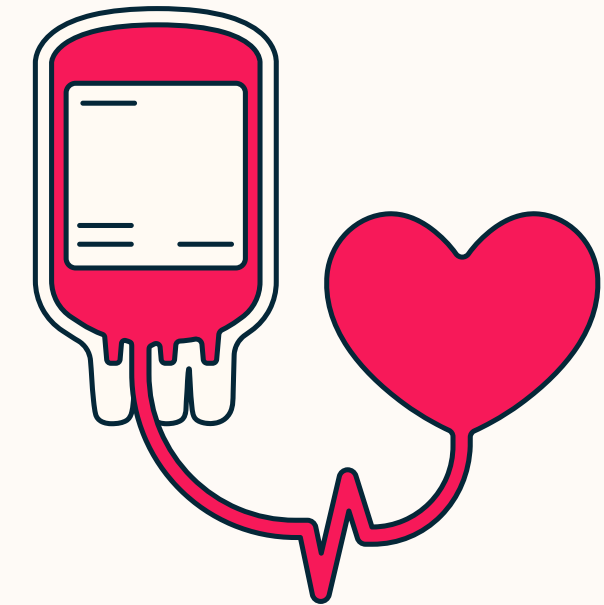
OBJETIVO DE REHABILITACIÓN

- Mejorar fuerza muscular residual en hombro
- Facilitar cambios posturales por decúbito
 - Entrenamiento familiar en traslados y cambios posturales
- Meta funcional: lograr alimentación autónoma con dispositivo de apoyo
 - Integrar musculatura residual en cambio postural de supino a lateral



EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Médicos rehabilitadores · Terapia física, ocupacional y de lenguaje · Enfermería · Nutrición · Psicología · Trabajo social



CONFIDENCIALIDAD

Se mantiene el anonimato de la paciente; se emplea un seudónimo para su identificación en el caso clínico.

Punto 2

FINANCIAMIENTO

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA



PRESENTA AYUDA DE SU FAMILIA



TRATAMIENTO REALIZADO EN



TRATAMIENTO FINANCIADO POR EL

SIS Seguro
Integral
de Salud

Punto 3

DIAGNOSTICO E HISTORIAL MÉDICO

COMPLICACIÓN SECUNDARIA

PRESENCIA DE SOBREPESO



BISACODILO 5 MG, 1
TABLETA VÍA ORAL CADA 24
HORAS.



GABAPENTINA 300 MG, 1-1-2
TABLETAS VÍA ORAL CADA 8
HORAS.



SIMETICONA 80 MG/ML, 40 GOTAS VÍA ORAL PRN
(SEGÚN NECESIDAD) POR DISTENSIÓN
ABDOMINAL.



LEVOTIROXINA 100 MCG, MEDIA TABLETA VÍA
ORAL CADA 24 HORAS (6:00 A. M.) POR 1 MES.



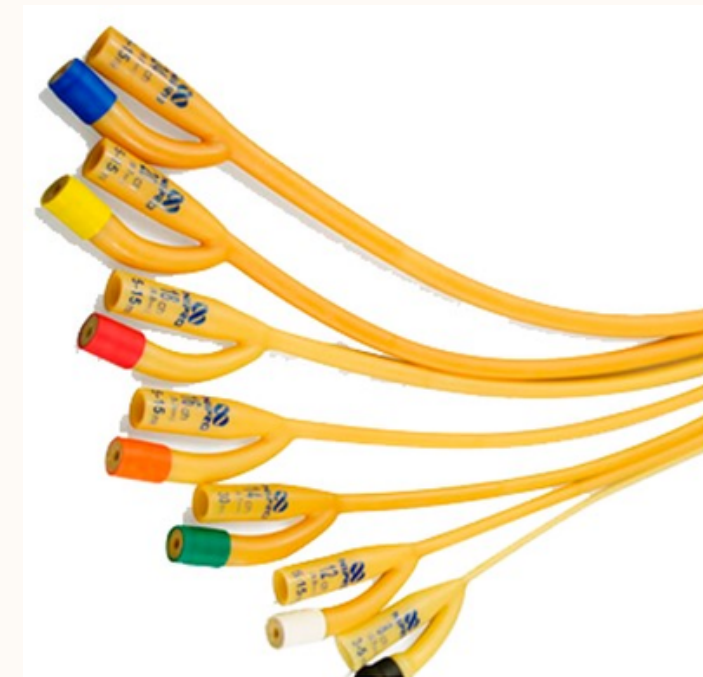
BACLOFENO 10 MG, TABLETA VÍA ORAL CADA 12
HORAS (1 - ½).



TERAPIA FÍSICA: SE MANEJA EL DOLOR DE HOMBROS CON COMPRESAS HÚMEDO-CALIENTES (CHC),
TERAPIA



MANEJO ESFINTERIARO MEDIANTE SONDA FOLEY



Punto 4

MOTIVACIÓN A LA LESIÓN

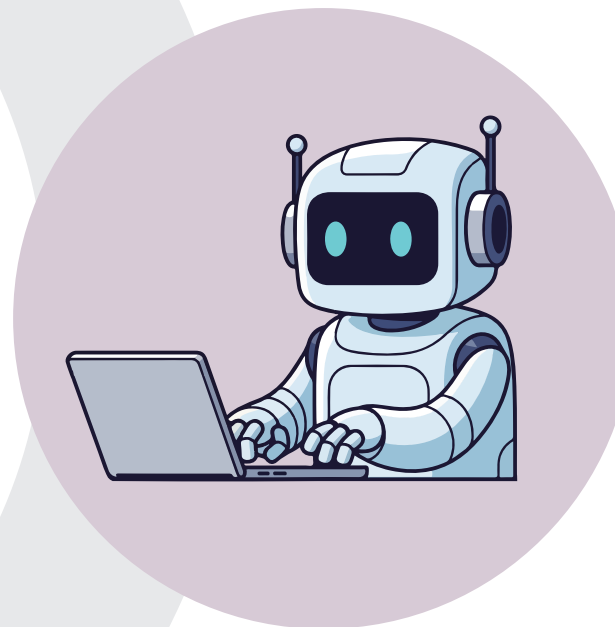
- Interés en las terapias
- Frustración por falta de independencia

DIFICULTADES

- Realizar traslados
- Baños y vestirse



ESTADO PSICOSOCIAL



TECNOLOGÍA

- Motivación con el uso de férulas y bachas
- Participación más activa

Punto 5

ESTADO NEUROMUSCULAR Y MUSCULOESQUELÉTICO

Control de cabeza

SEDESTACIÓN
LARGA Y CORTA



Posición/postura

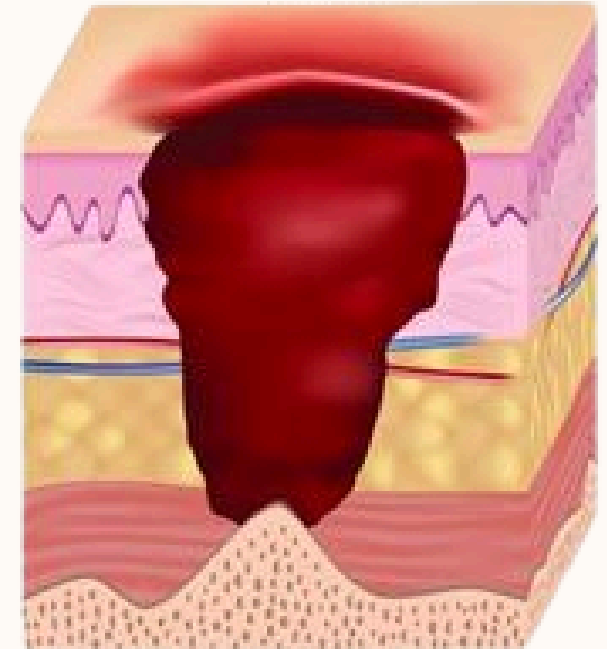
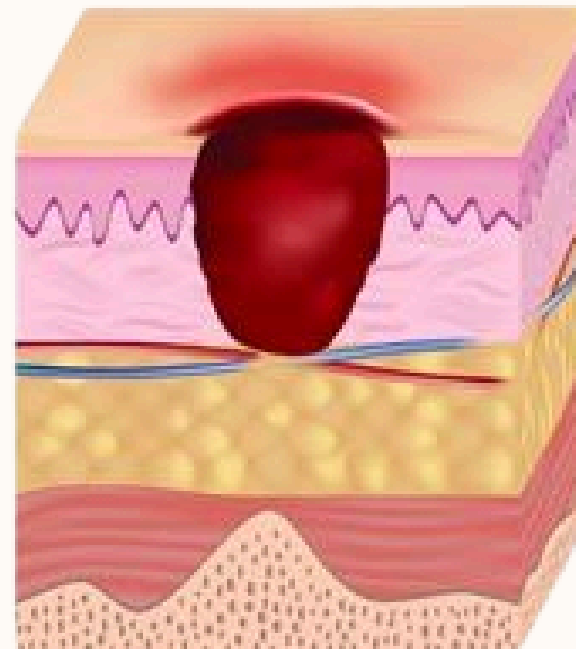
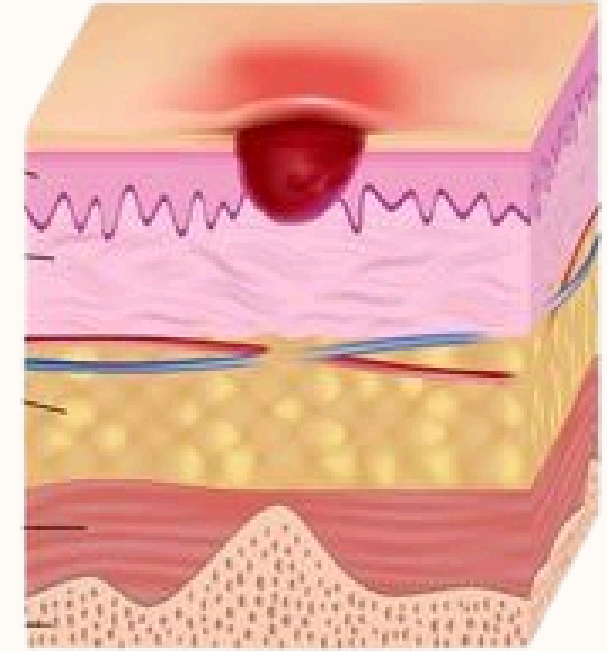
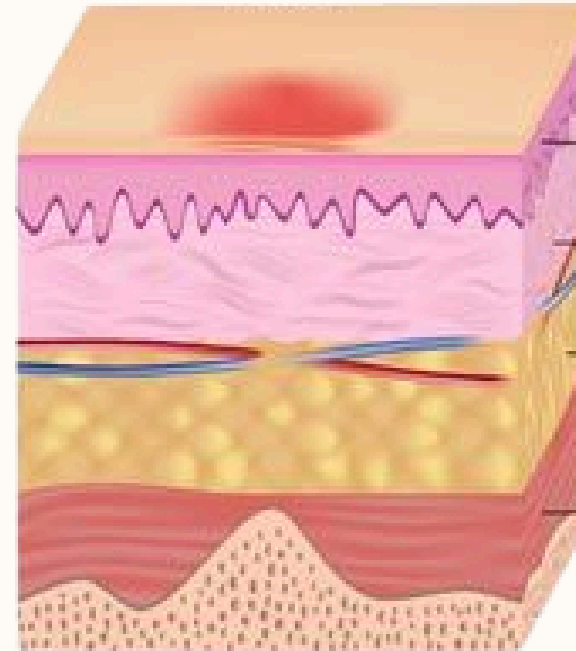
MAYOR
ESTABILIDAD
SOBRE UNA SILLA



Punto 6

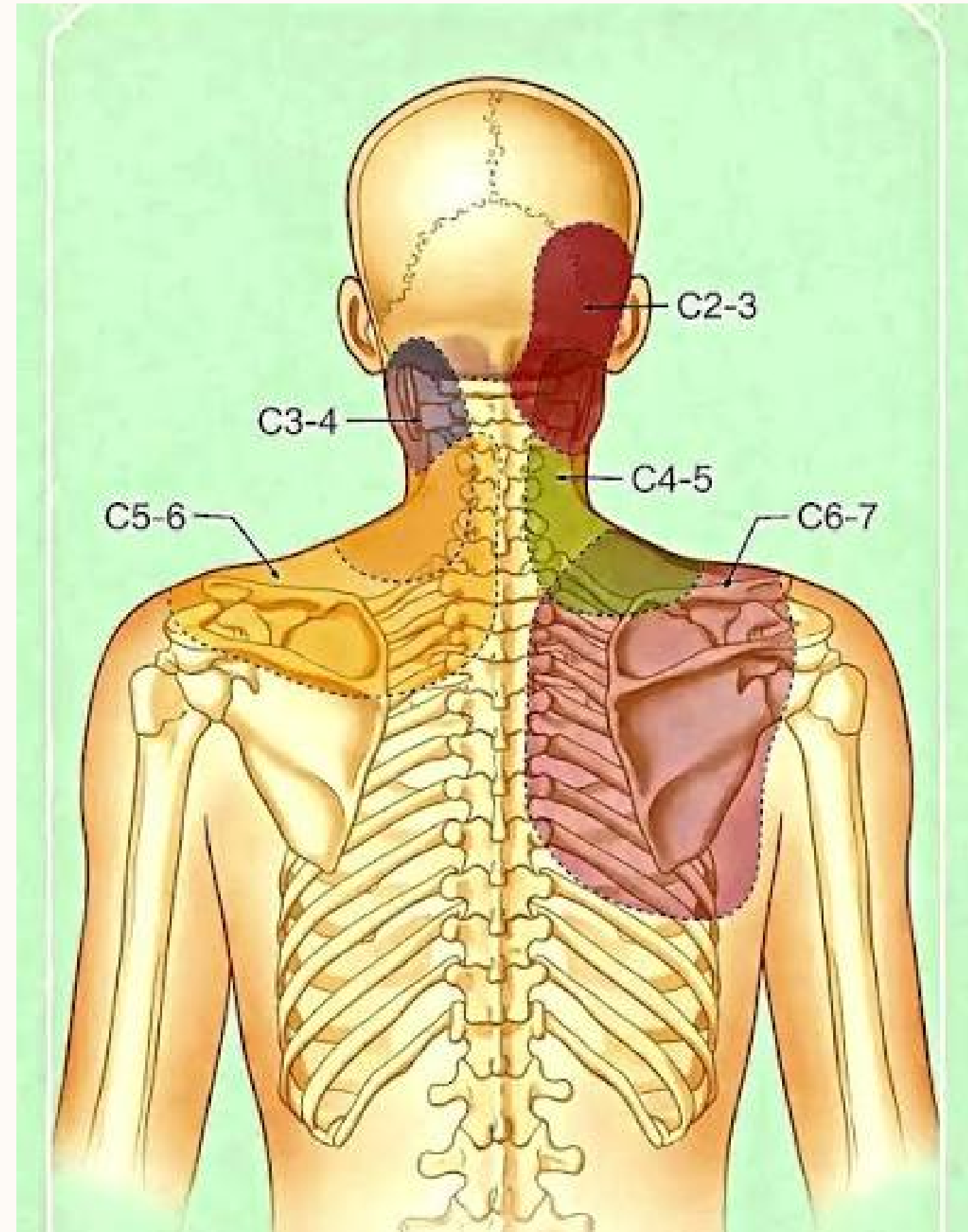
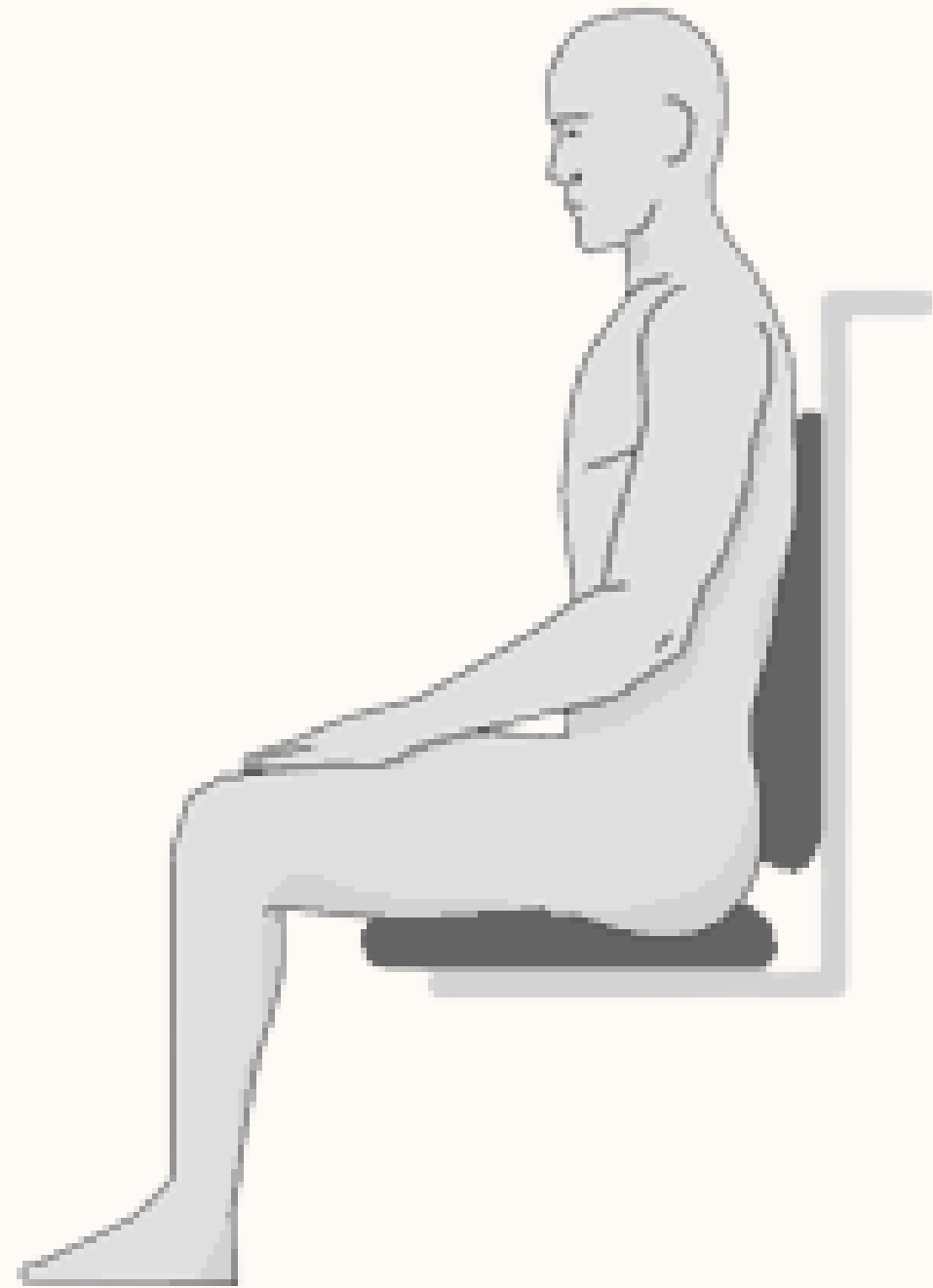
AFECTACIÓN A LA PIEL

-Se usa curaciones C/AQUACEL AG +Apósito antimicrobianos con plata iónica



Punto 7

FUNCIÓN SENSORIAL



Punto 8

Desempeño funcional, habilidades y tareas



- Usa celular, pero depende de otra persona para manipularlo.
- Una tecnología de asistencia podría facilitar cambios posturales y traslados, y reducir el esfuerzo de la cuidadora.

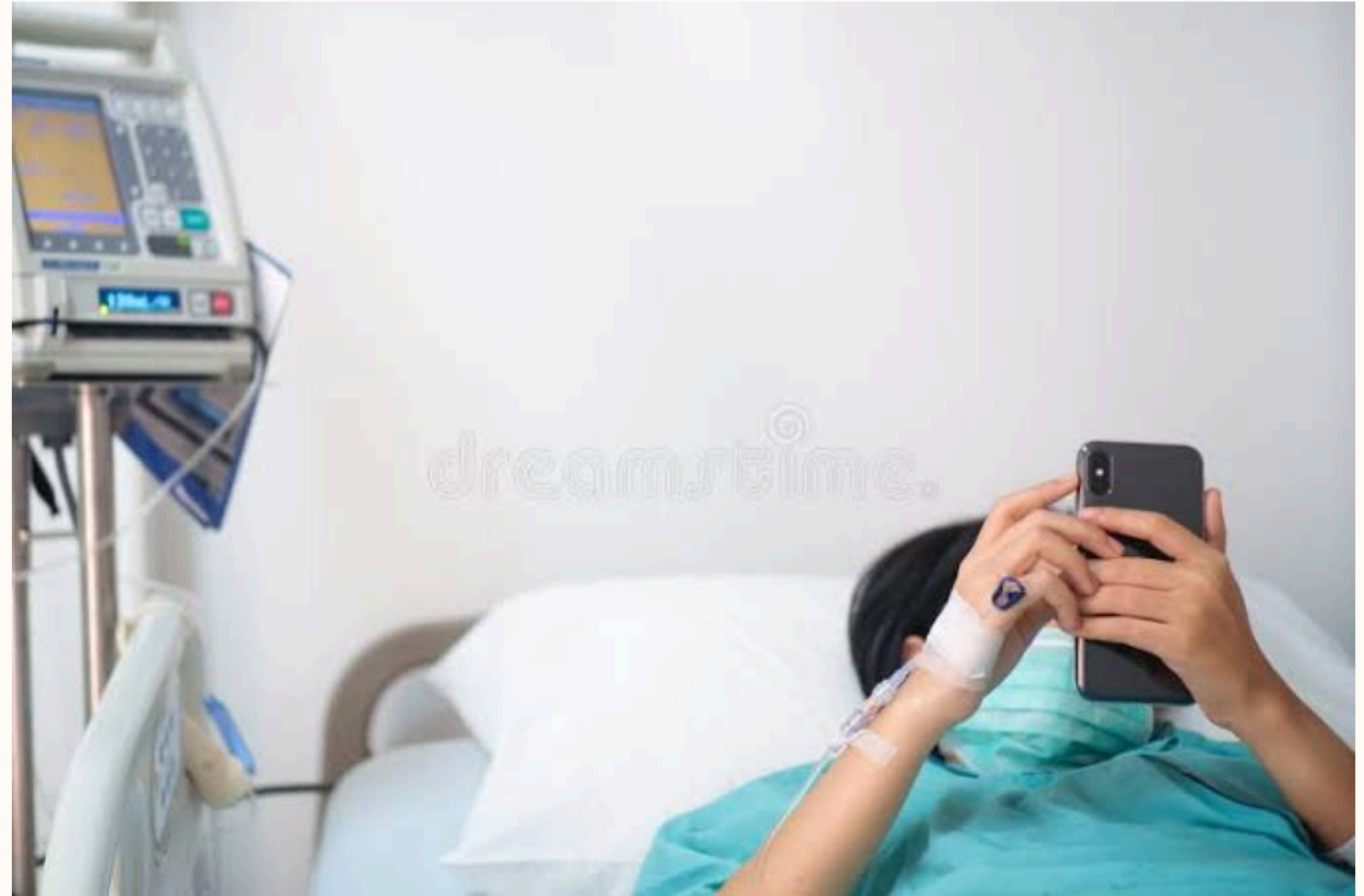
- En posición sentada y con apoyo de una mesa puede arrastrar objetos pequeños.
- Utiliza férulas extensoras de muñeca y apoyos para miembros superiores.

- Dependencia para realizar las actividades de la vida diaria (AVD).
- Requiere apoyo para traslados, baño y vestido.
- Participa parcialmente en la alimentación.



Punto 9

DESEMPEÑO FUNCIONAL Y AVD



Punto 10

Movilidad Personal

POSICIÓN HABITUAL

Permanencia diaria: aproximadamente 8 horas en cama y 4 horas en silla de ruedas, requiriendo rutinas estrictas de cambios posturales.

TRANSFERENCIAS

Los traslados entre cama, silla de ruedas y baño requieren la asistencia activa de 2 personas para garantizar la seguridad.

SILLA DE RUEDAS

Utiliza una silla de ruedas neurológica, la cual es totalmente controlada y maniobrada por la cuidadora debido a la plejía.

TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS

En el INR se utiliza grúa de transferencia; en el domicilio emplean una sábana deslizante para reducir sobrecarga y riesgo de lesión.

TRANSPORTE COMUNITARIO

Punto 11



MODO DE MOVILIZACIÓN

- Se moviliza en silla de ruedas
- Traslado mediante vehículo contratado para acudir a terapias y consultas

BARRERA IDENTIFICADA

El factor económico repercute en los traslados, ya que la paciente vive en Ancón y debe desplazarse hasta Chorrillos para recibir atención.

Punto 12

Entorno



- La vivienda no cuenta con adaptaciones de accesibilidad.
- Principales barreras:
 - Espacios reducidos.
 - Ausencia de rampas o accesos adecuados.
 - Dificultad para realizar transferencias y desplazamientos seguros.

- Cuenta con espacio suficiente para una posible tecnología de asistencia.
- Tiene acceso a electricidad.

- El acceso a internet es reducido.
- Cuenta con apoyo de su cuidadora.
- La tecnología propuesta debe adaptarse a las condiciones físicas y de conectividad del hogar.



Punto 13

Equipos y Tecnologías

EQUIPOS ACTUALES

- Férulas de Posicionamiento: Uso de OTP (órtesis tobillo-pie), bachas y extensores de muñecas.
- Soporte articular pasivo continuo.

ASPECTOS FAVORABLES

- Alineación Articular: Adecuado posicionamiento biomecánico de miembros superiores e inferiores.
- Prevención de Deformidades: Control eficaz de acortamientos y rigidez muscular.

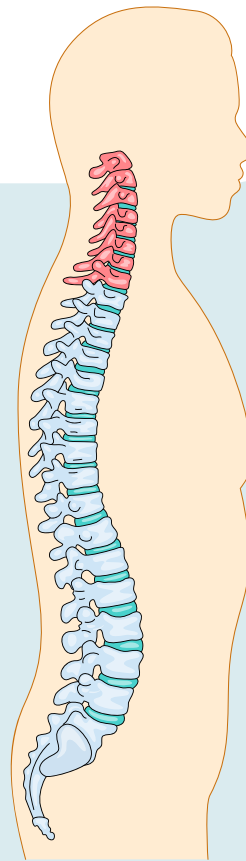
NECESIDADES PENDIENTES

- Soporte para Cambios Posturales: Alta necesidad de mayor apoyo técnico para el alivio sistemático de presión
- Dependencia Alta: Requiere asistencia considerable de la cuidadora para cada cambio de posición.

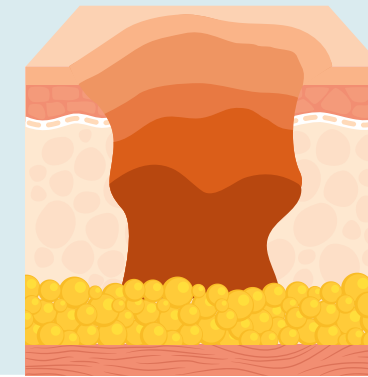
CASOS DE REFERENCIA

CASO 1

Hombre de 53 años con traumatismo de la médula espinal C2, AIS "A". Presenta pérdida casi total de función motora.



CASO 2



Hombre de 45 años con antecedente de lesión medular desde la infancia. Desarrolló una úlcera por presión isquiática crónica.

CASO 3

Mujer de 71 años con ACV isquémico y hemiplejia izquierda, con dependencia parcial para actividades diarias. Tras rehabilitación intensiva, mejoró su independencia funcional.



[1] P. Sharma, T. Panta, B. Ugiliweneza, R. J. Bert, Y. Gerasimenko, G. Forrest, and S. Harkema, "Multi-site spinal cord transcutaneous stimulation facilitates upper limb sensory and motor recovery in severe cervical spinal cord injury: A case study," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 12, no. 13, Art. no. 4416, 2023, doi: <https://doi.org/10.3390/jcm12134416>.

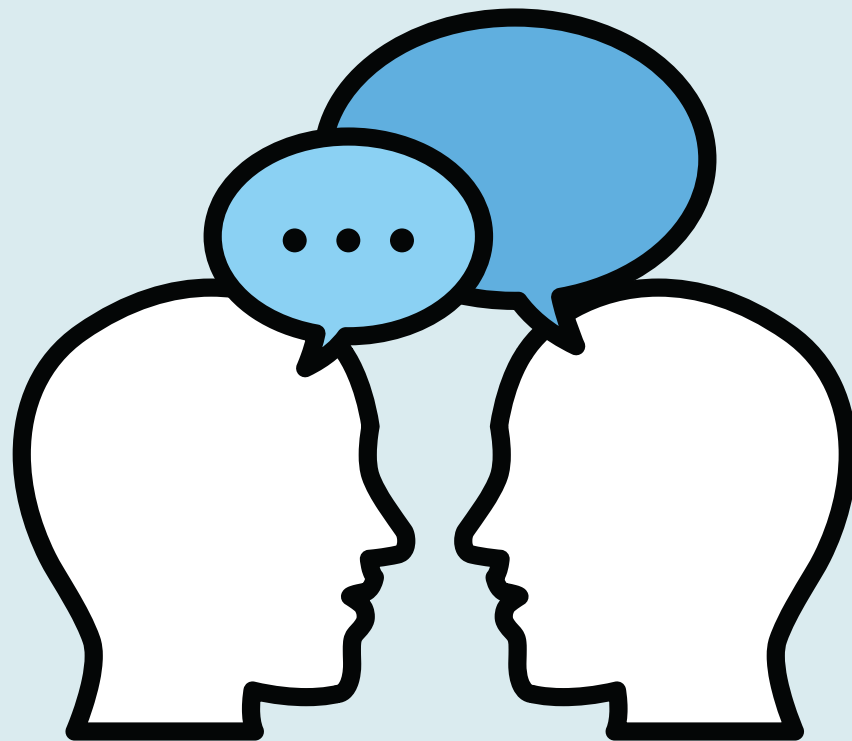
[2] C.-Y. Huang, Z.-Y. Hsieh, K.-C. Chang, and D.-H. Chang, "Marjolin's ulcer in an ischial pressure sore presented with necrotizing soft tissue infection: A case report," *Medicine*, vol. 102, no. 13, Art. no. e33450, 2023, doi: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000033450>.

[3] K. Nagai and F. Yamaguchi, "Improved functional independence measure facilitates return to home after paralyzed upper-limb training: A case report," *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 5, pp. 954–958, 2017, doi: <https://doi.org/10.1589/jpts.29.954>.

PERFIL FUNCIONAL

HABILIDADES CONSERVADAS

- Comunicación
 - Flexibilidad parcial en miembros superiores
- Motivación
- Participación laboral



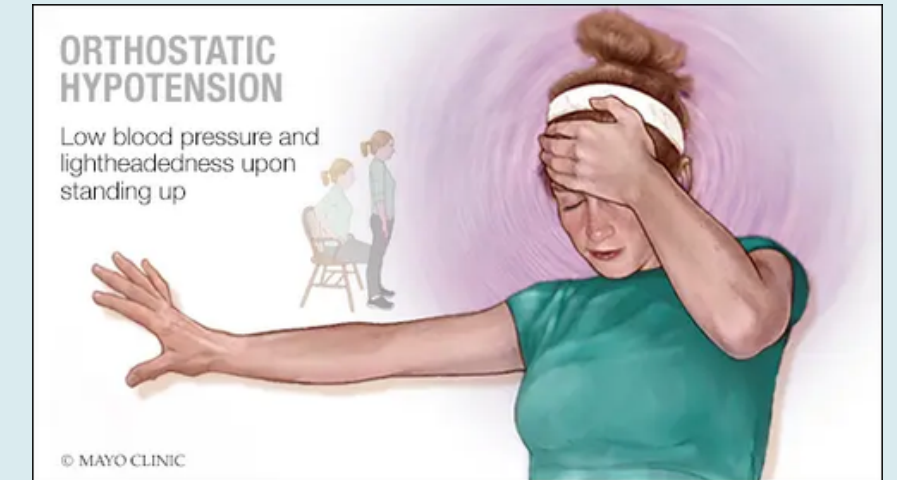
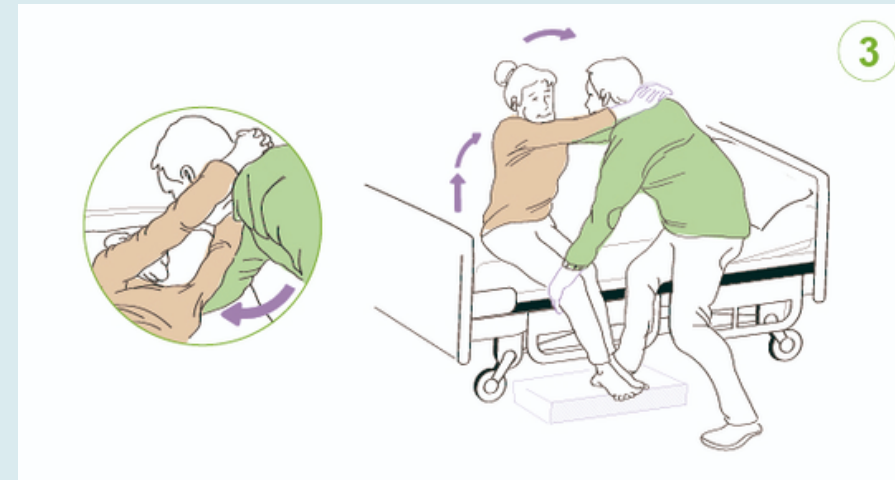
PRINCIPALES LIMITACIONES

- Control postural
- Dependencia Total
- Control del tronco
- Integridad de la piel
- Actividades de la vida diaria

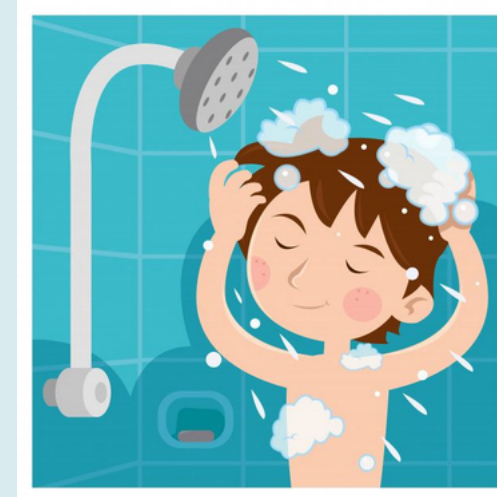


MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

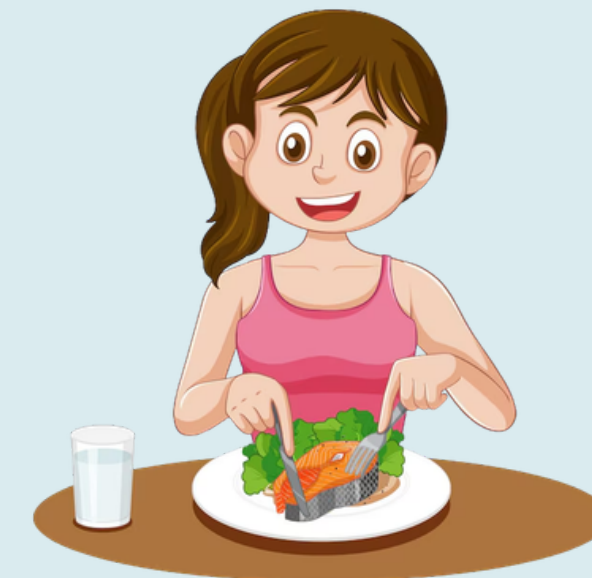
Traslados (Silla ↔ Cama): Dependiente. Nulo control de tronco, sobrepeso y mareos por hipotensión ortostática. Representa un alto esfuerzo y riesgo para el cuidador.



Vestido e Higiene (incluye baño): Dependiente. Incapacidad para mantener la postura o realizar cambios de posición de forma autónoma.



Alimentación: Parcialmente dependiente. Expresa necesidades verbalmente, pero requiere asistencia para el posicionamiento seguro en sedestación.

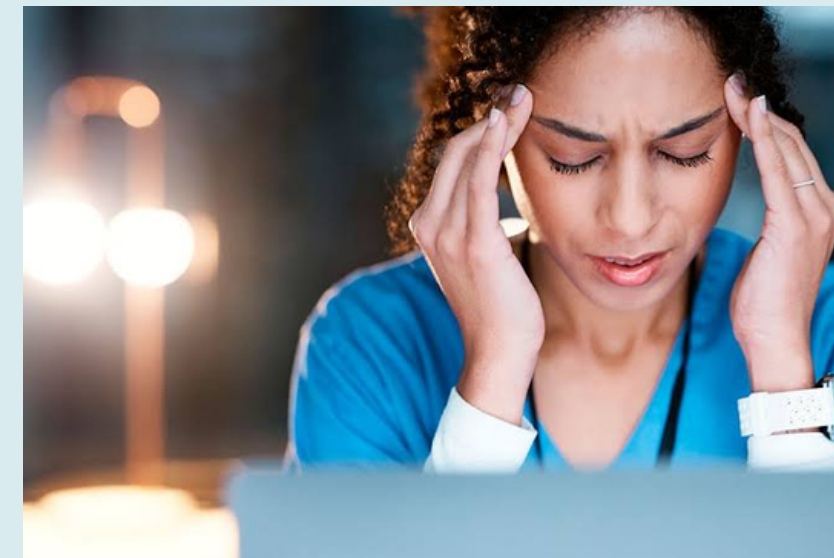


2. Laborales, Educativas y Comunitarias

Dirección de Eventos Sociales: Parcialmente independiente. Dirige y contrata personal externo (rol cognitivo/directivo conservado; ejecución física delegada).



Gestión Logística Domiciliaria: Parcialmente independiente. Limitada por la fatiga y los síntomas al estar sentada.



Participación Comunitaria / Grupos de Apoyo: Nula. No participa en actividades o talleres comunitarios fuera o dentro del INR.



No Participación

3. Rehabilitación (Lunes a Sábado - 50 min/sesión)

Fisioterapia: Dependiente. Dificultad crítica en sedestación por nulo control de tronco y mareos recurrentes por hipotensión ortostática.



Terapia Ocupacional: Dependiente. Enfocada en la tolerancia postural, adaptación del entorno y uso de asistencias.



Terapia de Lenguaje: Independiente / Parcial. Conserva la comunicación verbal fluida de necesidades básicas, con trabajo en el patrón respiratorio.



4. Prevención y Progresión

Uso de Férulas: Dependiente. Prevención de deformidades articulares y acortamientos musculares.



Ejercicios Domiciliarios y Respiratorios: Dependiente. Ejecutados por el cuidador previo entrenamiento para prevenir complicaciones pulmonares y rigidez.



Plan Nutricional Prescrito: Parcialmente dependiente. Control de sobrepeso para reducir el riesgo de úlceras por presión y facilitar las transferencias.



BARRERAS IDENTIFICADAS

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Hogar en Ancón no adaptado, con accesos reducidos, presencia de desniveles y ausencia total de rampas.

GEOGRAFÍA Y TRANSPORTE

Trayecto crítico y muy extenso desde Ancón hasta el INR (Chorrillos), requiriendo flete privado costoso.

CLÍNICA Y EQUIPAMIENTO

Dolor mecánico persistente en hombros, inestabilidad postural en sedestación y falta de colchón antiescaras.

SOCIOECONOMÍA Y CUIDADORA

Cese de ingresos por incapacidad laboral y alta sobrecarga física/emocional en la cuidadora principal.

TRASLADOS CAMA-SILLA

Mayor riesgo físico y demora



SEDESTACIÓN EN TERAPIA

Mareos por hipotensión ortostática

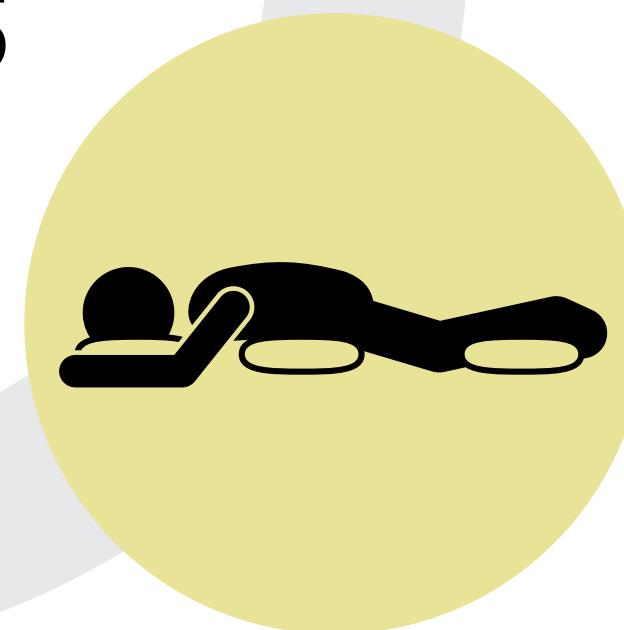


PAIN POINTS



DIMENSIÓN EMOCIONAL

Ansiedad y temor económico



DECÚBITO PRONO

Ejercicio evitado por dolor

EXPECTATIVAS DEL USUARIO

AUTONOMIA
FINCIONAL

MOVILIDAD

ROL FAMILIAR
Y SOCIAL

INDEPENDENCIA

REDUCCIÓN DE
CARGA DEL
CUIDADOR

SEGURIDAD



BIBLIOGRAFÍA

- [1] P. Sharma, T. Panta, B. Ugiliweneza, R. J. Bert, Y. Gerasimenko, G. Forrest, and S. Harkema, "Multi-site spinal cord transcutaneous stimulation facilitates upper limb sensory and motor recovery in severe cervical spinal cord injury: A case study," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 12, no. 13, Art. no. 4416, 2023, doi: <https://doi.org/10.3390/jcm12134416>.
- [2] C.-Y. Huang, Z.-Y. Hsieh, K.-C. Chang, and D.-H. Chang, "Marjolin's ulcer in an ischial pressure sore presented with necrotizing soft tissue infection: A case report," *Medicine*, vol. 102, no. 13, Art. no. e33450, 2023, doi: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000033450>.
- [3] K. Nagai and F. Yamaguchi, "Improved functional independence measure facilitates return to home after paralyzed upper-limb training: A case report," *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 5, pp. 954–958, 2017, doi: <https://doi.org/10.1589/jpts.29.954>.



**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**